

Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé

Le contenu et les qualités de l'information



Périmètre : ces recommandations actualisent et remplacent « Information des patients — Recommandations destinées aux médecins » (ANAES, mars 2000). Elles N'ABORDENT PAS : l'information sur des risques inconnus au moment de l'acte et révélés ultérieurement par la science ; l'information sur les circonstances et causes d'un dommage lié aux soins ; les pratiques de bioéthique ; l'information en fin de vie (régie par la loi du 22 avril 2005). Elles concernent l'ensemble des professionnels de santé (pas seulement les médecins).

AE

Convention de ce document : la grille HAS A/B/C/AE est définie en préambule, mais aucune citation individuelle n'apparaît dans le texte — la source énonce explicitement que « toutes les recommandations reposent sur un accord entre experts » (absence de données permettant un grade). Chip **AE** (accord d'experts) appliqué uniformément.

1. Le contenu et les qualités de l'information

Thème	Recommandation	Grade
Contenu	L'information porte sur l'état de santé, les investigations/traitements/actions de prévention envisagés, pour permettre à la personne de décider en connaissance de cause ; le professionnel décrit le suivi proposé et répond aux questions.	AE
Contenu	Elle porte sur : l'état de santé et son évolution habituelle (avec et sans traitement, qualité de vie) ; la description et le déroulement des actes envisagés et l'existence d'alternatives ; leurs objectifs, bénéfices, inconvénients, complications et risques fréquents ou graves prévisibles ; les précautions recommandées ; les modalités de suivi.	AE
Contenu	Présenter les différents choix possibles pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision, quelle qu'elle soit (accord ou refus).	AE
Qualités	L'information est synthétique, hiérarchisée, compréhensible et personnalisée ; elle présente les alternatives, puis les bénéfices attendus, puis les inconvénients et risques éventuels.	AE
Qualités	Elle porte sur les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, sur les risques graves (pronostic vital ou fonctionnel), ainsi que sur les risques spécifiques à la personne et les précautions particulières associées.	AE
Qualités	Le professionnel s'assure de la compréhension (ex. faire reformuler), indique la proposition qu'il préfère en expliquant ses raisons, et propose un second avis si nécessaire.	AE

Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé

Les modalités de la délivrance de l'information



2. Les modalités de la délivrance de l'information

Thème	Recommandation	Grade
Entretien individuel	La délivrance se fait toujours dans le cadre d'un entretien individuel, avec tact et disponibilité ; elle peut être progressive, réitérée et actualisée si nécessaire.	AE
Entretien individuel	La volonté d'une personne de ne pas être informée est respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.	AE
Avec accompagnant	S'assurer du souhait de présence de l'accompagnant et proposer qu'une partie de l'entretien se fasse en tête-à-tête, sauf opposition de la personne.	AE
Avec accompagnant	Recourir à un interprète pour une personne étrangère, ou à un assistant de communication en cas de handicap sensoriel ou moteur, est recommandé.	AE
Personne de confiance	Si désignée et si le patient a choisi de s'en faire assister, l'entretien a lieu en sa présence, avec un temps en tête-à-tête proposé.	AE
Documents écrits	L'information orale est primordiale ; des documents écrits peuvent la compléter (jamais à faire signer par la personne).	AE
Documents écrits	Les documents sont hiérarchisés, fondés sur des données validées, présentent les bénéfices avant les inconvénients/risques, précisent les risques fréquents et graves, les moyens de faire face aux complications et les signes d'alerte ; ils sont synthétiques, clairs et courts.	AE
Documents écrits	Il est souhaitable de disposer de documents en langues étrangères et de supports adaptés (malvoyance, troubles du développement...).	AE
Plusieurs professionnels	Chaque professionnel informe sur son domaine de compétence sans présumer que l'information a été donnée par un autre, mais s'enquiert de ce qui a déjà été délivré ; un référent unique remet une synthèse aux différentes étapes du soin.	AE
Traçabilité	Le dossier mentionne les informations majeures délivrées, par qui, à quelle date, et les difficultés éventuellement rencontrées.	AE
Traçabilité	Ces mentions suffisent comme moyen de preuve en cas de litige — il n'y a pas lieu de demander à la personne une confirmation signée.	AE

Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé

Information du mineur/majeur protégé, évaluation & sources



3. Information du mineur, du majeur protégé ou inapte

Thème	Recommandation	Grade
Mineur	Le droit à l'information est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, mais le mineur reçoit lui-même une information adaptée à son degré de maturité pour l'associer à la décision (le dossier trace les deux informations).	AE
Mineur	Si les deux titulaires sont présents : informer les deux ainsi que le mineur ; un temps d'entretien singulier avec le mineur peut être proposé selon son âge.	AE
Mineur	Si un seul titulaire est présent : l'informer et lui exposer la nécessité d'informer l'autre titulaire (en particulier si les parents sont séparés) ; un entretien avec les deux parents peut être proposé si le pronostic est grave.	AE
Mineur	Si l'accompagnant n'est pas titulaire de l'autorité parentale : lui délivrer une information strictement utile et nécessaire, à compléter avec le(s) titulaire(s).	AE
Mineur	Mineur non accompagné : l'informer si sa maturité et la situation clinique le permettent, en indiquant si besoin la nécessité de réitérer l'information en présence du/des titulaire(s).	AE
Mineur	Mineur s'opposant à l'information des titulaires pour garder le secret : le médecin (seul, et non tout professionnel de santé) peut mettre en œuvre le traitement nécessaire à la sauvegarde de sa santé sans autorisation parentale, à condition que le mineur se fasse accompagner d'un majeur de son choix.	AE
Majeur protégé	Le majeur protégé reçoit lui-même l'information, adaptée à ses facultés de compréhension (principe d'autonomie, loi du 5 mars 2007) ; le juge des tutelles peut prévoir que le tuteur la reçoive en sa présence, ou seul si le majeur n'est pas en état de la recevoir.	AE
Majeur inapte	Information adaptée aux facultés de compréhension ; consulter la personne de confiance si désignée alors que la personne avait encore ses facultés, ou à défaut les proches présents — en traçant dans le dossier le motif et le contenu de l'information donnée.	AE

4. Évaluation de l'information donnée

Thème	Recommandation	Grade
Satisfaction	La satisfaction des personnes à l'égard de l'information orale et écrite fait l'objet d'une évaluation rétrospective par les établissements de santé (ex. commissions des relations avec les usagers).	AE
Pratiques	Une évaluation régulière des pratiques d'information devrait s'appuyer sur des enquêtes auprès des personnes et sur l'analyse rétrospective des dossiers médicaux.	AE
Documents écrits	L'évaluation des documents vérifie la méthode d'élaboration et le contenu scientifique, l'identité des auteurs et la date d'établissement, et l'absence de toute signature demandée à la personne (contrôlé en visite de certification HAS).	AE

Sources et avertissement

Document source : Haute Autorité de Santé (HAS), « Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé », Recommandation de Bonne Pratique, validée par le Collège de la HAS en mai 2012.

URL source : <https://sfar.org/delivrance-de-linformation-a-la-personne-sur-son-etat-de-sante/>

Couverture : intégralité des 4 sections de recommandations (28 items, tous AE — grille A/B/C/AE définie en préambule mais jamais citée individuellement, la source énonçant explicitement que toutes les recommandations reposent sur un accord d'experts). Annexe 1 (liste réglementaire des professions de santé) et la section Participants non reproduites — non actionnables au chevet. Divergence de date disclosed en tête de script (index bibliothèque : 2010 ; document : mai 2012) et lien source corrigé (coquille dans l'URL de l'index). Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire en anesthésie-réanimation. Elle ne remplace pas le texte intégral ni un conseil juridique. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la HAS.